

ICUコミュニケーションのstate of the art — 医師は情報源から「案内人」へ、定型的家族面談 から日々の非公式な対話へ(総説・ICM2026)

出典 Ashana DC, Cox CE. ICU communication: 'state of the art'. Intensive Care Med. 2026;52(6):1333-1335. doi:10.1007/s00134-026-08364-y

掲載誌 Intensive Care Medicine(2026-06)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08364-y(本文PDFは別途)

原題 ICU communication: 'state of the art'



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わること(1)**: 家族対応の重心を「節目の家族面談」から「毎日の短い声かけ」へ移す。当院の3ステージICプロトコルは節目の質を担保する仕組みとして残しつつ、その間を埋める非公式な日々のcheck-in(アジェンダなし・数分・多職種の誰でも)を明示的に業務に組み込む余地がある
- **変わること(2)**: 家族の未充足ニーズの拾い方を広げる。この総説が引く先行研究では、家族が挙げるニーズは意思決定上の葛藤よりも患者の症状・経済的困窮・スピリチュアルな不安が多い。宿泊費・休業損失といった医療外の困りごとはMSW・チャプレンにつなぐ経路をあらかじめ用意しておく(Hotel ICUの退室後訪問と地続きの話)
- **変わること(3)**: 予後不確実性を明示的に扱う道具として時間制限つき治療トライアル(TLT)を面談の標準オプションに置く。当院の多職種カンファとERRSの運用に載せやすい
- **変わらないこと**: 面談技法のニモニック(SPIKES等)や構造化フレームワークを捨てる話ではない。著者の主張は「構造化だけでは足りない」であり、標準化の価値そのものは否定していない
- **研究・QIへの示唆**: ICUの家族支援介入を評価するとき、6か月後のPTSD・不安を主要評価項目にしない。ICU在室中の症状・ストレス・未充足の緩和ケアニーズ・経済的困窮といった短期の当事者アウトカムを主軸に据える。アンケート設計時に自由記述(本人の言葉)を必ず残す



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: ICUのコミュニケーションは、構造化フレームワークと意思決定を中心とした公式の医師-家族面談として体系化されてきた (ESICMの終末期・緩和ケアガイドライン2024がその到達点)。共感的で創造的な研究チームによる家族支援介入も多数試みられてきた
- **Unknown**: それら介入の大半が患者中心アウトカムを臨床的に意味のある大きさに改善できていない理由。真に効いていないのか、測り方が悪いのか
- **What's new**: 社会の側の変化 (医療への信頼低下、情報アクセスの民主化、AI・SNS、文化的多様化、慢性疾患化による予後不確実性の増大) が臨床コミュニケーションの前提を変えたと整理し、(1) 内容とプロセス、(2) 介入の設計、(3) アウトカムの選び方——の3層で転換を提案する。とくに「アウトカム問題を解かない限り偽陰性の試験が続ぎ、臨床医のコミュニケーション・ニヒリズムを招く」という指摘が新しい



全体要約

要旨

ひとことで 情報アクセスの民主化と信頼の低下により、ICU医師の役割は「医学情報の唯一の供給源」から**信頼を築き情報の海を案内するガイド**へ移った。著者は内容・介入・アウトカムの3層で転換を提案し、なかでも**長期アウトカム偏重こそがICUコミュニケーション試験を偽陰性にしている**と論じる。

- 集中治療の場は特殊: 進行が速く患者は脆弱、患者と関係が未確立の大人数チームが関わり、死が日常的に起こる。だから交わす言葉が重い
- 過去10年で起きた地殻変動: 医療機関への公衆の信頼低下、患者・家族による医療情報 (自分の診療データを含む) へのほぼ無制限のアクセス、SNSとAIによるデータ解釈の補助、グローバル化と公平性重視で文化規範が意思決定に及ぼす影響の増大、そして生命限定的疾患を慢性疾患に変える生物医学の進歩による予後予測の不確実化

- 内容とプロセス:アジェンダを決めない短い日々のcheck-inへ。「語る」より「聴く」、家族とその文化に関心を持つ。家族が真に困っていること(宿泊費・休業)はここで初めて出てくる
- 家族面談が必要な複雑例でも医師の役割は変質:複数の情報源(と誤情報)を家族が渡り歩くのを助け、予後不確実性を認めて治療に協働的な境界線を引く時間制限つき治療トライアルを取り入れる
- 既存介入の限界は4つ:現代的な伝達手段(モバイルアプリ等)を組み込んでいない/ICU在室中しか使えない/訓練された介入者に依存しスケールしない/単一言語・単一多数民族集団でしか検証されていない
- 将来の介入に必要なもの:縦断的ニーズ、文化的・言語的多様性、実装時に格差を生まない無駄のないスケラブルな構造。モバイルアプリとAIは単純なニーズへの対応・緊急/複雑ニーズの適任者へのトリアージ・ケア移行をまたぐ伴走支援・リアルタイム翻訳を低資源で実現しうる。施設文化そのものに働きかける介入も必要
- ただし技術がどうであれ、臨床医は**患者の価値観や医学的状況に沿わないAIの提案には異を唱える**人間的専門ガイドとしての矜持を保たねばならない
- アウトカム問題:6か月後の不安症状のような長期アウトカムが助成審査員と編集者に期待され続けているが、ICU内介入の作用機序と長期アウトカムはミスマッチ。短期の当事者アウトカムを副次に落とすことは「その場の症状やストレスの改善に価値はない」と誤って示唆する。多次元的な介入をスイスアーミーナイフに例えれば、現状は刃1枚の性能だけで全体を測っている

詳細

1. まず前提 — この議論の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む ICUの「コミュニケーション」研究は、家族との公式面談をどう構造化するかを軸に発展してきた。VALUE (Value family statements／Acknowledge emotions／Listen／Understand the patient as a person／Elicit questions)やSPIKES、NURSEといった二モニツクはその産物で、ESICMの終末期・緩和ケアガイドライン2024にも定型面談の推奨が並ぶ。介入研究の代表例が本文で引かれる：**PARTNER** (多職種の家族支援、NEJM2018)、**communication facilitator** (AJRCCM2016)、**nurse facilitator** (ICM2024)、**FICUS** (看護師主導の家族支援、JAMA Intern Med 2025)、**家族参加プログラム** (CCM2024)、そして著者自身の**モバイルアプリ型プラットフォーム** (JAMA Netw Open 2024)。多くは「介入は届いたが、家族の不安・抑うつ・PTSDといった長期心理アウトカムは改善しなかった」という結果に終わっている。用語：**GOC (goals of care)** = 治療のゴール。**TLT (time-limited trial)** = 期間と評価指標をあらかじめ決めて集中治療を試し、期限で再評価する枠組み (ATS公式ワークショップ報告2024で定義)。**DNAR** = 蘇生を試みない指示。**moral distress** = 正しいと思う行為ができないことによる臨床医の道徳的苦痛。**PICS/PICS-F** = 集中治療後症候群 (-Fは家族版)。**wraparound support** = ICU・一般病棟・外来を通して切れ目なく伴走する支援。

2. Introduction — なぜICUのコミュニケーションは特別か

患者と家族が病を航行するのを助けるのは、すべての臨床医の仕事の一部である。良いコミュニケーションはあらゆる医療の場で重要だが、集中治療の文脈は次の3点で固有だと著者は述べる。

集中治療に固有の条件	なぜ言葉の重みが増すか
進行の速さと患者の臨床状態の脆さ	判断の猶予が短く、状況が数時間で変わる
患者と確立した関係を持たない大人数チームの関与	信頼の蓄積がないところから始めざるを得ない
死が日常的に起こるという厳粛な現実	一つひとつの会話が最後の会話になりうる

本稿の射程は「情報アクセスとコミュニケーションにおける社会変化が、すでに集中治療医の話し方をどう変えているか」、そして「その変化が次世代のコミュニケーション戦略と介入をどう形づくるか」の2点である。

3. 何が現代の臨床コミュニケーションを変えたのか

過去10年は、コミュニケーション規範の地殻変動(seismic changes)の10年だったとする。列挙される変化は以下。

変化	内容	帰結
権威の喪失	医療への公衆の信頼低下に伴い、医学知識の権威ある供給源としての臨床医の役割が縮小	「医師が言うから」が通らない
情報アクセスの民主化	患者・家族は自分の診療データを含む医療情報に、ほぼ無制限の独立性でアクセスできる	面談前に家族はすでに調べ終えている
解釈支援の普及	SNSとAIツールの一般化が医療データの解釈を助ける	解釈の質が担保されないまま結論が先に立つ
文化規範の前景化	グローバル化と公平性への注目の高まりで、文化規範が医学的意思決定に及ぼす影響が増大	単一の価値観を前提にできない
予後の不確実化	生物医学研究がかつての生命限定的疾患を慢性疾患へ急速に変え、重症患者の予後予測の不確実性を深めている	「見通し」を語る足場が弱くなった

これらが合わさって、臨床医を医学情報の唯一の供給源とする図式から、**信頼を築くこと**、そして**個別化され価値観に整合したコミュニケーションと現代医学の限界とのバランスをとる**ことに臨床医が注力すべき時代へと移行が起きた。だからこそ2026年時点でICUのコミュニケーションを再考する必要がある、というのが本稿の出発点である。

4. 時の試練に耐える戦略と、新たに強調すべき方向

4-1. 内容とプロセス — 定型面談から日々の非公式な対話へ

ICUコミュニケーションの標準的な内容とプロセスは、構造化フレームワークと意思決定に焦点を当てた公式の医師-家族面談として特徴づけられてきた。著者はこのアプローチを、コミュニケーションを標準化するためにかつては必要だったと認めつつ、家族が情報へのアクセスを得た現在は**もはや最適ではないかもしれない**と述べる。

代わりに提案されるのは、次の具体像である。

従来	これから	理由
節目に行く公式面談	アジェンダを設けない短い日々のcheck-in	信頼確立という現在の優先事項を支えやすい
伝える(telling)	聴く(listening)	シンプルな技法が大きく効く
医学的問題に焦点	家族とその文化に好奇心を持つ	医療外の困りごとが出てくる場になる

このような場でこそ、家族は最も重大な気がかりを口にできる。例として挙がるのは**宿泊費や休業による収入減**——重症疾患そのものとは直接関係しないが、MSWなど多職種チームメンバーが対処しうる問題である。実際、近年のデータでは家族は未充足ニーズとして、意思決定上の葛藤(decisional conflict)といった従来型の問題よりも、**患者の症状・経済的困窮・スピリチュアルな不安**をより多く報告している。

家族への先取りのな接触(proactive connections)が重要な理由は2つ。威圧的になりうる家族面談という文脈の外で起こること、そして医学的決定が求められる前に起こること。加えて、**臨床医側のmoral distressを減らす**効果も期待できると著者は述べる。

4-2. 家族面談が必要な複雑例でも、医師の役割は変質した

面談がなお必要な複雑例においても臨床医の役割は変わった、と著者は主張する。今の面談は次の用途に使われうる。

- 家族が複数の情報源(そして誤情報)を渡り歩くのを助ける
- 予後不確実性を認め、集中治療の範囲に協働的な境界線を引く**時間制限つき治療トライアル(TLT)**のようなアプローチを取り入れる

5. 既存のコミュニケーション介入の4つの限界

近年、共感的で創造的な研究チームによる思慮深いICUコミュニケーション介入がいくつも設計されてきた。しかし**その大半は患者中心アウトカムを臨床的に重要な大きさに改善できなかった**。著者はこの種の介入の限界を4点に整理する。

#	限界	具体的に何が問題か
1	現代的な伝達手段を組み込んでいない	モバイルアプリなど、今の人が実際に使うモダリティが入っていない
2	ICU在室中しか使えない	その後の入院チーム・外来チームへ介入を橋渡しすることが難しいため
3	スケールしない	訓練された介入者 (interventionist) に依存する設計だから
4	単一言語・単一集団での検証	提供言語が1つに限られ、検証も1つの多数派民族集団のみ

6. 将来の介入に求められる要件

著者が「謹んで提案する (respectfully suggest)」将来の介入の優先事項は3つ。**患者・家族の縦断的ニーズ、文化的・言語的多様性、そして実装過程で格差を生まないリーン(無駄のない)でスケーラブルな構造である。**

モバイルアプリとAIに期待される具体的な機能は次のとおり。

機能	内容
単純なニーズへの対応	定型的なコミュニケーション需要をアプリ・AIが吸収する
選択的トリアージ	緊急または複雑なコミュニケーションニーズを、それに最も対処できる人へ選択的に振る
伴走支援 (wraparound)	ケアの場をまたいで切れ目なく支える
リアルタイム翻訳	言語の壁をその場で下げる
低資源での実装	限られた資源でも導入できる

さらに、**施設文化 (institutional culture) の要素を組み込むか直接扱う介入**も必要だとする(引用されるのはICUスタッフのバーンアウトを減らすpositive communicationのクラスターRCT)。

ただし技術や革新がどうであれ、臨床医は**人間的な専門ガイド (expert humanistic guides) としての矜持を保たねばならない**。その例として著者が挙げるのは、患者の価値観や医学的状況に沿わないAIプラットフォームの治療提案に対して、あえて異を唱える意思を持つことである。

7. アウトカムの問題 — 「コミュニケーション・ニヒリズム」

最後に、ICUコミュニケーション介入を評価するアウトカムそれ自体が進化しなければならない、と論じる。6か月後の不安症状のような長期アウトカムは今なお助成審査員と雑誌編集者に期待されているが、これは複数の理由で問題だとする。

問題	論旨
機序とのミスマッチ	ICU内で完結する介入の作用機序と、長期アウトカムとの間にずれがある
短期アウトカムの格下げ	短期の当事者アウトカムを副次的地位に置くことは、その場の症状やストレスの改善に価値がないと誤って示唆する
尺度が狭すぎる	多次元的なコミュニケーション介入の影響をとらえるには、よく使われる測定尺度は狭すぎる可能性が高い

著者の反問がそのまま論旨を要約している——ICUでの強い痛みや不安からの解放は、6か月後のPTSD症状を減らして初めて価値をもつのか。

多次元介入を単一尺度で測る現状は、**スイスアーミーナイフの全体的効果を、道具1つの評価だけで測っているようなものだ**と喩える。必要なのは、良いコミュニケーションが改善しうる多数の領域——ストレス、症状、意思決定、尊厳、聴かれ理解されているという感覚——をよりよく反映し、かつ**患者と家族自身の言葉を取り込める革新的なアウトカム**である。

今後より重視すべき短期アウトカムとして具体的に挙がるのは以下。

対象	短期アウトカム
患者	経験している身体症状
患者と家族の双方	心理症状、未充足の緩和ケアニーズ、経済的困窮

△ 注意

偽陰性が生む「コミュニケーション・ニヒリズム」アウトカムの問題が解決されない限り、ICUを基盤とするコミュニケーション試験は**偽陰性の結果を報告し続け**、臨床医のあいだに「コミュニケーションでは何も変わらない」という**ニヒリズム**を育ててしまう。効かない介入だと結論する前に、測り方を疑う必要がある。

8. Figure — ICUコミュニケーションの過去・現在・未来

図の解説

Figure. ICUを基盤とするコミュニケーションの過去・現在・未来の概観。横4段・縦3列のマトリクスで、左端に茶色の角丸ボックス(従来の重心)が4つ縦に並び、そこから右へ、灰茶色の枠内に「Historical focus(従来の焦点)」、中央に紫枠のピンクのグラデーション帯で「Factors of promoting change(変化を促す要因)」、右に緑の矢印で「Emerging directions(新たな方向)」が伸び、矢印の先の緑の角丸ボックスに到達点が置かれる。中央のピンク帯は4段すべてに共通して縦に貫く1本の柱として描かれ、5つの小見出し(Information access/Information type and meaning/Information exchange/Information context/Participants involved)が上から順に並ぶ。柱から各段の緑矢印へ、山形の切り込みで接続している。

各ボックスの文言を段ごとに起こす(原図・無改変)。

8-1. 4つの段(左=従来の重心/右=到達点)

従来の重心	Historical focus(従来の焦点)	Emerging directions(新たな方向)	到達点
構造化されたコミュニケーション	意思決定／予後告知／GOC・DNAR・対立	その場での改善を試みる／信頼と関係構築に focus／予後不確実性を受け入れる／忍耐と時間制限つきトライアル／言語と文化を統合する	より柔軟なコミュニケーション
主たる伝達者としての臨床医	公式・断続的な面談／医師が情報を提供／コミュニケーションのモニック／交渉	臨床医が技術のアウトプットを患者の価値観に整合させる／傾聴・非公式さ・柔軟性・頻回の関与／臨床医が患者と家族のために情報源をキュレートする／GOCは時間とともに変わると認識する	案内人・ガイドとしての臨床医
複雑なICU基盤の介入	多要素／標準化された内容／ICU期間に限定	よりシンプル・軽いタッチ・プラグマティック／単一または複数の提供者に適応可能／ICUから病棟、外来への連続性／情報を個別化できる	介入を支えるテクノロジー
長期アウトカム重視	長期志向／心理的苦痛／コードステータスの変更／予後理解／在室日数	短期の当事者中心アウトカム(例:ICU在室中)／未充足ニーズとストレスに焦点／参加者自身の言葉を取り込む形で影響を包括的に評価する新しい方法論	当事者中心・多次元のアウトカム

8-2. 中央の柱「変化を促す要因」(5ブロック)

ブロック	挙げられている要因
Information access(情報アクセス)	インターネット検索能力と医療情報の広範な入手可能性／電子カルテの記録・検査結果へのアクセス／解釈のためのAI
Information type and meaning(情報の種類と意味)	グローバル化・移民・文化的変化／話される言語の多様化／翻訳・通訳サービスへのアクセス増加
Information exchange(情報のやりとり)	モバイル技術／ソーシャルメディア／テキスト・メールなど迅速なコミュニケーション手段／ラウンドへの家族の参加
Information context(情報の文脈)	治療モダリティと支持療法の複雑化／予後への影響が不明な治療薬の爆発的増加／長期在室を伴う介入の拡大(例:ECMO、VAD)／医療アクセスと提供に対する政府の影響
Participants involved(関与する人々)	オンライン支援グループ／インターネットから情報を得ることへの安心感と信頼の増大／医師への信頼と信用の低下／病院内に存在するプライマリケア医の消失

9. 著者のTake-Home Messages(原文の3層)

論文末尾に置かれた著者自身のtake-homeは以下の3項目(3つ目は3つの下位項目を持つ)。

層	内容
社会変化	臨床コミュニケーションに関わる主要な社会変化:医療機関への公衆の信頼低下、医療情報への公衆のアクセス拡大、進行中の文化的混合(cultural admixture)、生命延長ケアの限界を押し広げる医学的進歩
役割の変化	その結果、ICU臨床医の役割は医学情報を提供することから、信頼を築き、個別化されたコミュニケーションと倫理的義務とのバランスをとることへ移った
提案:内容とプロセス	周期的・集中的な家族面談から、傾聴と全人的ニーズを優先する頻回で非公式なコミュニケーションへ移る
提案:介入	ケアの場・言語・国ごとの文脈を橋渡しする、スケーラブルで低資源の伴走支援を重視する
提案:アウトカム	短期・当事者中心・多次元のアウトカムを優先する

10. Conclusion

人々が情報を集め、コミュニケーションする方法の深く継続的な変化に歩調を合わせるため、コミュニケーションのパラダイムを更新し介入を適応させることが重要である。臨床ケアと研究を進化・改善させるには、**現状維持を促す停滞(stasis)の要因**を認識するとともに、**革新と変化を促す現代的要因**を受け入れるべきだと結ぶ。

11. 批判的吟味(JCでの論点)

- **区分は総説であり実証ではない。**新規データはなく、示される因果(社会変化 → 介入の失敗 → 測定の問題)はすべて著者の解釈である。Figureも文献ベースの概念図で、各要因の寄与度は定量化されていない
- **「日々の非公式なcheck-inのほうが良い」を支持するRCTは示されていない。**提案の根拠は「家族の未充足ニーズは意思決定葛藤より症状・経済・スピリチュアルに多い」という観察データ(Cox 2023)と著者の臨床判断。非公式化が本当に信頼を高め、かつ意思決定の質を落とさないかは未検証。頻回の接触は臨床医の時間コストを増やす一方で、その資源評価も本稿にはない
- **論理が循環しかねない箇所がある。**「介入が効かなかったのはアウトカムが不適切だったから」は魅力的だが、短期アウトカムに切り替えれば有意差が出る保証はなく、短期指標の改善が本当に患者・家族にとっての利益かも別途示す必要がある。反証可能な形で提示されていない
- **AIの位置づけが両義的。**低資源でのトリアージ・翻訳の担い手として期待しつつ、価値観に沿わないAI提案には異を唱えよと求める。実装上どこで線を引くのか(誰がAI出力の妥当性を検証し、責任を負うのか)は述べられていない
- **著者の利害:**モバイルアプリ型介入のRCT(Cox 2024)は著者自身の研究であり、「現代的モダリティを組み込め」という提案は自らの路線の擁護でもある。金銭的COIはないと明記されているが、知的な利害は残る
- **文脈の一般化可能性:**議論の土台は米国(プライマリケア医が病院に姿を見せなくなった、医療アクセスへの政府の影響)。日本のICUでは主治医制・家族の同席文化・費用負担構造が異なり、「信頼低下」の程度も同一とは言えない。ただし言語・文化的多様性の課題は在日外国人の増加という形で当院にも当てはまる
- **「communication nihilism」は診断名ではなく修辞。**臨床医の諦めを表す便利な言葉だが、その存在も程度も測られていない

12. 主要な引用文献一覧

#	内容	出典
1	COVID-19下のEU諸国における医療機関への信頼低下の多面的分析	Yaddanapudi L, et al. Discover Public Health. 2024;21(1):117
2	米国成人50州調査：パンデミック期の医師・病院への信頼	Perlis RH, et al. JAMA Netw Open. 2024;7(7):e2424984
3	ESICM ICU終末期・緩和ケアガイドライン(従来型の構造化面談の到達点)	Kesecioglu J, et al. Intensive Care Med. 2024;50(11):1740-1766
4	ICUの緩和ケアニーズの軌跡と長期心理的苦痛(未充足ニーズは症状・経済・スピリチュアルが多い根拠)	Cox CE, et al. Crit Care Med. 2023;51(1):13-24
5	重症患者の時間制限つき治療トライアル(TLT)の定義:ATS公式ワークショップ報告	Kruser JM, et al. Ann Am Thorac Soc. 2024;21(2):187-199
6	看護師ファシリテーターによる家族コミュニケーション促進RCT	Kentish-Barnes N, et al. Intensive Care Med. 2024;50(5):712-724
7	ICUの家族支援介入RCT(PARTNER)	White DB, et al. N Engl J Med. 2018;378(25):2365-2375
8	コミュニケーション・ファシリテーターによる家族苦痛と終末期ケア強度の低減RCT	Curtis JR, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2016;193(2):154-162
9	モバイルアプリ型コミュニケーション促進プラットフォームのRCT(著者自身)	Cox CE, et al. JAMA Netw Open. 2024;7(1):e2349666
10	看護師主導の家族支援介入 FICUS クラスターRCT	Naef R, et al. JAMA Intern Med. 2025;185(9):1138-1149
11	標準化された家族参加プログラムの多施設段階的ウェッジRCT	Dijkstra BM, et al. Crit Care Med. 2024;52(3):420-431
12	ICUコミュニケーションにおける文化的コンピテンスの涵養	Siddiqui S, Metaxa V. Intensive Care Med. 2025;51(3):599-602
13	重症疾患のShared Decision Makingにおける人種差	Ashana DC, et al. JAMA Intern Med. 2024;184(4):424-432
14	重篤な患者の終末期ゴール・選好の不安定性(システムティックレビュー)	Murali S, et al. JAMA Netw Open. 2025;8(11):e2541264

#	内容	出典
15	ICUスタッフのバーンアウトを減らすpositive communicationのクラスターRCT	Azoulay E, et al. Intensive Care Med. 2025;51(11):2031-2041

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 情報アクセスの民主化と信頼の低下により、ICU医師の仕事は「情報を渡すこと」から「**信頼を築き、情報と誤情報の海を家族と一緒に航行すること**」へ移った。明日から変えられることは2つ。**節目の家族面談の合間に、アジェンダのない数分のcheck-inを日々差し込み、「語る」より「聴く」ことに時間を使う**（宿泊費・休業といった医療外の困りごとはそこで初めて出てくる。MSW・チャプレンへつなぐ経路を先に用意しておく）。そして予後が読めない症例には、**期限と評価指標を決めた時間制限つき治療トライアル(TLT)**を面談の標準オプションに置く。研究・QIでは**6か月後のPTSDを主要評価項目にするのをやめる**。ICU在室中の症状・ストレス・未充足の緩和ケアニーズ・経済的困窮を主軸に据え、自由記述で当事者自身の言葉を残す。**測り方を変えないままの偽陰性が、現場のコミュニケーション・ニヒリズムを育てている。**

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。